

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME DE BURNOUT EN
INTERNOS DE MEDICINA DE HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PAZ, MEDIANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB, FEBRERO – JUNIO 2026.**

DOCENTES:

- **Dra. Miriam Doritza Bautista Callisaya**

ESTUDIANTES:

- **Caceres Ccoarite Leidy Nikol**
- **Calla Ayma Cinthia Elizabeth**
- **Escobedo Estofanero Jhadde Vanessa**
- **Marquez Divapuri Lucia Nataly**
- **Panca Apaza Rosaura**
- **Quispe Castro Sheyla Mayly**
- **Rodriguez Cordova Albert Pablo**
- **Sucapuca Apaza Mary Cielo**
- **Ticona Quispe Ana Yulissa**

LA PAZ

2026

DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo, con profunda gratitud, a nuestras familias, quienes han sido la base firme que nos sostuvo a lo largo de este camino. Su acompañamiento silencioso, sus palabras de aliento en los momentos difíciles y su constante fe en nuestras capacidades nos brindaron la fuerza necesaria para seguir adelante. Gracias por enseñarnos, con su ejemplo, el valor del esfuerzo, la perseverancia y la unidad.

Extendemos esta dedicatoria a nuestros compañeros y amigos, con quienes compartimos jornadas interminables de estudio, desafíos, desvelos y también instantes de alegría que hicieron más ligero el trayecto. Cada apoyo, cada conversación y cada meta compartida hicieron de este recorrido una experiencia significativa y memorable.

Y finalmente, agradecemos a Dios por concedernos la sabiduría, la fortaleza y la oportunidad de culminar este esfuerzo. A Él encomendamos cada paso dado y cada logro alcanzado.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos profundamente a la Universidad Privada Franz Tamayo, institución que nos brindó el espacio ideal para desarrollarnos tanto en lo académico como en lo personal. Su compromiso con la formación integral nos otorgó las herramientas necesarias para transformar el aprendizaje en práctica y convertir nuestras metas en logros concretos.

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los internos de los diferentes hospitales públicos de La Paz que participaron en este estudio. Su disposición, colaboración y tiempo fueron fundamentales para la obtención de la información que dio sustento a esta investigación. Este proyecto no habría sido posible sin su valioso aporte.

Finalmente, expresamos nuestra más sincera gratitud a nuestras familias y amigos, quienes han sido nuestra fuerza constante. Su apoyo incondicional, motivación y comprensión nos acompañaron en cada etapa del proceso. Este trabajo representa no solo un resultado académico, sino también el fruto del esfuerzo compartido y del respaldo de quienes siempre confiaron en nosotros.

ÍNDICE

RESUMEN:-----	5
1. INTRODUCCIÓN-----	7
2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA-----	9
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN-----	13
4. OBJETIVOS-----	13
4.1. OBJETIVO GENERAL-----	13
4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO-----	13
5. JUSTIFICACIÓN-----	14
6. MARCO REFERENCIAL-----	17
6.1. ANTECEDENTES-----	17
6.2. MARCO TEÓRICO-----	23
6.3. MARCO CONCEPTUAL-----	35
7. HIPÓTESIS-----	41
7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES-----	41
CUADRO N° 1:CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES QUE SE CONSIDERARÁN EN EL ESTUDIO-----	42
8. METODOLOGÍA-----	44
8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN-----	44
8.5. TÉCNICA-----	46
8.6. INSTRUMENTO-----	46
8.7. POBLACIÓN-----	47
CUADRO N°2: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.-----	49
9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS-----	50
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-----	52
CUADRO N° 3-----	52
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-----	52
12. PRESUPUESTO-----	54
CUADRO N°4-----	54
RESUMEN DE INVERSIONES DE LOS GASTOS.-----	55
13. RESULTADOS-----	56
14. DISCUSIÓN-----	57
15. CONCLUSIONES-----	59
16. BIBLIOGRAFÍA-----	60
17. ANEXOS-----	66

RESUMEN:

El Síndrome de Burnout no es agotamiento pasajero, es una falla estructural en la respuesta al estrés crónico que se caracteriza por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. En internos de medicina expuestos a jornadas extremas, presión asistencial y privación crónica de sueño, este síndrome no solo destruye la salud mental, sino que deteriora la calidad de atención al paciente y aumenta el riesgo de errores médicos.

Bolivia lidera el estrés laboral en América Latina (55%), pero carece de estudios sistemáticos sobre Burnout en internos de medicina de hospitales públicos; la evidencia existente es fragmentada: un estudio de la UMSA (2023) encontró 54.4% de agotamiento emocional en estudiantes, pero ningún trabajo ha medido el fenómeno en el escenario real del internado hospitalario con herramientas tecnológicas.

Por primera vez en el contexto local, una herramienta digital permitirá la detección temprana, el monitoreo continuo y la generación de evidencia replicable; los resultados no se quedan en el diagnóstico, sino que permitirán diseñar estrategias de intervención, manejo del estrés y mejora de condiciones laborales para transformar la formación médica.

La metodología empleada se basa en un enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y un diseño transversal. Para la recolección de datos, se implementó un sistema web (LAISO). El instrumento principal es el Maslach Burnout Inventor (MBI) , completando con la Escala de Estrés Percibido (PSS). Se espera que los resultados evidencien una asociación significativa entre el estrés laboral, la privación de sueño y el desarrollo de las dimensiones del Burnout .

El síndrome de Burnout en internos de medicina no es un problema individual, es un problema del sistema, e identificarlo con precisión mediante plataformas web como LAISO es el primer paso para intervenir. Este estudio proporciona la base empírica para hacerlo.

PALABRAS CLAVES

- Despersonalización
- Estrés
- Cansancio

1. INTRODUCCIÓN

El síndrome de burnout se define como una manera poco apropiada de enfrentar un estrés emocional crónico frente al trabajo, caracterizado por cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, aunque se ha añadido un cuarto de componente en el contexto estudiantil, conocido como negative learning emotion (emoción negativa frente al aprendizaje).

En los internos de medicina, el rigor académico y otros factores de tensión a los que se ven sometidos pueden provocar síndrome de burnout, trastorno que, a su vez, produce bajo sentido de pertenencia con la institución, bajo rendimiento académico, consecuencias negativas en la atención al paciente e incluso intentos de suicidio. Por ello, las instituciones de educación superior y hospitales, cuya premisa es ofrecer una enseñanza de calidad, requieren ejecutar programas para notificar y manejar el síndrome de burnout entre su cuerpo estudiantil.

Igual que ocurre con los profesionales formales, los alumnos universitarios pueden enfrentar contextos donde padecen riesgos y perjuicios psicosociales ante estresores y demandas habituales colosales o inapropiadas, crónicamente no resueltas o de manera poco apropiada, que dependen de los entornos organizacionales de educación superior, de la labor académica de los alumnos y de componentes psicológicos individuales no propicios.

Ante esta situación, los estudiantes pueden ofrecer respuestas no adaptativas y dañinas como el denominado síndrome de quemarse por los estudios (burnout académico), con las consecuentes secuelas negativas para su salud psicosocial o bienestar psicológico, para su papel y trayectoria académica, insatisfacción con los estudios y, en consecuencia, el abandono escolar.

De la misma manera, este síndrome provoca alteraciones en los sistemas fisiológicos (en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso autónomo) como disfunciones psicofisiológicas manifestadas por cefalea, complicaciones cardiovasculares, digestivas y sexuales. Asimismo, puede provocar una inmunodepresión que incrementa el riesgo de infecciones como la gripe y desarrolla

la probabilidad de enfermedades inmunológicas. Además, los cambios cognitivos propician un conjunto de sesgos o dificultades en la interpretación de la conducta, la activación fisiológica y el pensamiento, que provocan la adquisición de un conjunto de dudas irracionales y alteraciones de tipo emocional (1).

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

El síndrome de burnout y el crecimiento de los estados de estrés y depresión en la población general, en especial en los profesionales de la salud, se considera un problema en el mundo laboral de la actualidad y afecta a diferentes profesionales que por lo general tienen contacto directo con las personas, por lo cual estas situaciones generan ansiedad, depresión, frustración, poca autoestima, nerviosismo y soledad.

Las altas exigencias académicas, los horarios prolongados y el estar al cuidado y atención de pacientes, son situaciones a las que los estudiantes de Medicina en el internado rotatorio se enfrentan diariamente, estas situaciones aunque son vitales para la formación de un profesional de la salud, exponen a los estudiantes a altos niveles de estrés, muy bien puede significar la presentación del SB, haciéndolos 2 a 3 veces más propensos a buscar escapar de la realidad a través del alcohol, consumo de sustancias psicoactivas e incluso la ideación suicida, en comparación a los que no lo presentan (1).

El síndrome de burnout está presente a nivel mundial, y según el contexto puede llegar a tener una prevalencia de hasta un 80.05%, esto que es bastante alarmante y puede llegar a ser un problema de salud pública, estos suelen presentarse sobretodo en personas las cuales tienen un ambiente laboral “estresante”(2).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este síndrome es consecuencia del estrés laboral crónico no gestionado, a nivel global, diversos estudios reportan que entre el 40% y el 50% de los profesionales de la salud presentan burnout, alcanzando cifras superiores al 50% en médicos, especialmente en contextos de alta demanda. Este síndrome se presenta con mayor frecuencia en profesiones con elevada carga emocional y responsabilidad, como enfermería, medicina y docencia, donde factores como largas jornadas laborales, sobrecarga asistencial y presión constante contribuyen a su desarrollo. Además, el burnout no solo afecta el bienestar del trabajador, sino que también se asocia con una

disminución en la calidad de atención, aumento de errores profesionales y mayor riesgo de trastornos mentales(3).

A nivel Latinoamérica a pesar de la limitación de estudios sobre el tema muestra que la prevalencia va variando según la situación sanitaria, ya que en época de la pandemia por COVID-19 las tasas de prevalencia podían llegar a subir desde 36% hasta 76% a raíz del estrés vivido (4).

A nivel Bolivia se puede evidenciar la falta de estudios relacionados al tema, pero igual indican que tanto docentes, estudiantes y personal de salud pueden reportar prevalencia variada; docentes de unidades educativas reportan con un 29% con cansancio emocional y 17% con despersonalización(5). Asimismo se reportó en estudiantes de medicina alrededor de un 22 a 24 % en la década presente, específicamente en 2023 (5).

Un estudio realizado por Salinas Nina (2023), titulado “Prevalencia y distribución del síndrome de Burnout Student en estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés”, identificó una prevalencia del 14,4 % del síndrome en esta población, siendo la dimensión de agotamiento emocional la más afectada, con un 54,4 % de los casos. Aunque el estudio no abordó directamente los trastornos del sueño, sus resultados reflejan el impacto del estrés académico y la carga emocional en los estudiantes de educación superior en Bolivia, evidenciando la necesidad de investigar los factores asociados al bienestar mental en este grupo (6).

También el poder identificar diferencias en el sexo y ocupación ayudan a poder revisar cuál es la población más vulnerable frente al síndrome de Burnout, así tenemos que mujeres suelen reportar más despersonalización y factores asociados a síndrome de Burnout, asimismo la población más frecuente a desarrollar son personas con un trabajo exigente y estresado o bajo presión, lo indica el estudio de diferencia en edades y sexo con Burnout, donde asimismo la población de personal de la salud suele reportar más casos de Burnout en mujeres con un 55% frente al 47% en varones(7).

El síndrome de Burnout no está relacionado a un tipo de raza o etnia en específico, pero sí suele estar más presente en personas de grupos o etnias minoritarias de una sociedad, esto a raíz de la discriminación, mayor carga administrativa y mayor intención de dejar una profesión. Pero este no está relacionado a una etnia o raza en específico, sino al contexto social y laboral de manera personal (7).

Diversos estudios han mostrado que el uso de terapias de relajación, grupos de soporte por parte de médicos entrenados, tutores en el caso de médicos con mayores responsabilidades, uso y disponibilidad de dinero, mayor control sobre rotaciones y horarios, entre otros, se asocian a una menor prevalencia de Burnout(8).

Los programas de intervención se desarrollan a tres niveles estratégicos: individual (considerando estrategias de afrontamiento al estrés), interpersonal (potenciando la formación de habilidades sociales y las estrategias relacionadas con el apoyo social en el trabajo), organizacional (eliminando o disminuyendo estresores del entorno institucional)(8).

A nivel individual, las estrategias se centran en la adquisición y mejora de estilos de afrontamiento. Según Matteson e Ivancevich se clasifican en: Programas dirigidos a estrategias instrumentales (para la solución de problemas) y, programas dirigidos a estrategias paliativas (para el manejo de las emociones asociadas) (8).

Dentro de los primeros, se ubican las técnicas de resolución de problemas y asertividad, manejo del tiempo en forma eficaz, optimización de la comunicación, cambios en el estilo de vida, etc. Entre los segundos, cabe destacar el entrenamiento y adquisición de habilidades para expresión de emociones, el manejo de sentimientos de culpa y la relajación. Los afrontamientos activos o centrados en la solución del problema están considerados los más efectivos para la prevención y manejo del Burnout (8).

Como resultado de esta intervención se observó que no hubo diferencia significativa en la prevalencia de burnout entre las cifras encontradas al principio y al final del estudio en el grupo experimental, ni con respecto al grupo control. La única diferencia observada fue una mejora con respecto a la despersonalización en el

grupo experimental. En otra experiencia realizada en Madrid, se evaluó la influencia que tuvo una intervención psicoterapéutica grupal intensiva sobre el estrés y el burnout en un equipo de enfermería oncológica(9).

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout en internos de medicina de hospitales públicos de La Paz durante el periodo febrero-junio de 2026, y de qué manera se implementa una plataforma web contribuye a su identificación?

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar los factores de riesgo asociados al síndrome de burnout en internos de medicina de hospitales públicos de La Paz, mediante la implementación de una plataforma web, febrero – junio 2026.

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Identificar la relación que existe según los niveles de estrés laboral entre los internos de medicina de los Hospitales públicos de La Paz de acuerdo a la escala de estrés percibido (PSS 10).
- Relacionar los factores de riesgo y las dimensiones del síndrome de Burnout asociados al estrés laboral en internos de medicina de los hospitales públicos de La Paz.
- Identificar la dimensión del síndrome de burnout más afectada en los internos de medicina de hospitales públicos de La Paz según la escala de Maslach.
- Comparar las diferencias de resultados obtenidos mediante la plataforma LAISO entre los internos de medicina de los diferentes hospitales públicos de La Paz.
- Relacionar las horas de guardia y horas de sueño como factores asociados de riesgo con las dimensiones de síndrome de Burnout en los internos de medicina de los hospitales públicos de La Paz.

5. JUSTIFICACIÓN

El síndrome de Burnout, descrito por Christina Maslach, caracterizado por el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, llega a afectar severamente la salud y el desempeño de los trabajadores. La prevalencia de este síndrome es un problema frecuente tanto en la población como en el personal de salud, especialmente en alumnos que se encuentran en el último año de formación en la carrera de Medicina Humana, internado médico, en esta etapa se empieza la transición entre el ámbito académico y el laboral, donde se combinan las exigencias propias de la formación teórica entre la universidad con las responsabilidades asistenciales del hospital (10,11).

La responsabilidad y exigencia en ambos campos implica una elevada carga de trabajo, presión por el desempeño clínico y la necesidad constante de actualización de conocimientos y prácticas, esto incrementa los niveles de estrés que representan un grupo particularmente vulnerable como son los internos de medicina de los hospitales públicos de La paz, debido a las condiciones propias de su etapa formativa. El exceso de carga laboral, las guardias prolongadas, la presión académica y la responsabilidad progresiva en la atención de pacientes generan un entorno favorable para desencadenar frustración y por ende el desarrollo de estrés (11).

Estas condiciones sumadas a la poca experiencia clínica y a la estructura jerárquica del sistema de salud, aumentan el riesgo de desarrollar síndrome de Burnout. En consecuencia, los internos se convierten en una población altamente susceptible al desarrollo de burnout, lo cual afecta su bienestar físico, mental y la calidad de la atención brindada en el hospital (11).

En el presente estudio, el síndrome de Burnout y el estrés percibido se consideran factores cruciales para el análisis de la salud mental en internos de medicina. Para la evaluación del síndrome de Burnout se emplea el instrumento Maslach Burnout Inventory, diseñado para medir el grado de afectación de una persona frente a este síndrome.

Este cuestionario permite identificar tres dimensiones fundamentales como son el agotamiento emocional, que refleja la fatiga, cansancio y la sensación de llegar al límite; la despersonalización, caracterizada por actitudes distantes y desinteresadas hacia los pacientes; y la baja realización personal, que implica una percepción de ineficacia y falta de logro en el ámbito profesional (13).

Al aplicar este instrumento podemos llegar a cuantificar el nivel de Burnout y también comprender la forma en que este se manifiesta en los individuos facilitando su incidencia y análisis.

A su vez el estrés percibido será evaluado mediante la Perceived Stress Scale (PSS) escala diseñada para medir el grado en que las situaciones de la vida son valoradas como estresantes por el individuo, esta herramienta consta de ítems que exploran la percepción de control, sobrecarga y capacidad de afrontamiento frente a eventos cotidianos permitiendo estimar el nivel de estrés experimentado en un periodo determinado (12).

La inclusión de ambas variables resulta pertinente, ya que el estrés percibido constituye un factor asociado relevante en el desarrollo del síndrome de burnout, facilitando así una comprensión más integral del fenómeno en la población estudiada.

En cuanto al síndrome de Burnout, este consta de cuatro niveles, leve que se evidencia con malestar, apatía, reproches sin fundamento y dificultad para desarrollar sus actividades; moderado, caracterizado por actitudes negativas, aislamiento, y cinismo; grave, relacionado con la automedicación, necesidad de consumir fármacos y ausencia laboral; extremo, presenta sintomatología psiquiátrica que puede llegar a conllevar al suicidio (10).

Las consecuencias de padecer burnout en los internos de medicina llega a afectar el ámbito individual y por ende repercutir directamente en la calidad del sistema de salud. A nivel personal se relaciona con trastornos de salud mental, ansiedad y depresión acompañado de un bajo rendimiento académico y clínico. A nivel institucional contribuye a errores médicos, disminución en la calidad de la atención y

afecta la relación médico-paciente, lo que convierte a este síndrome en un problema de salud pública (11).

Aunque este tema sea relevante y significativo por tales motivos y consecuencias, no existen estudios de gran cantidad que estudien de manera profunda e integral el síndrome de Burnout y sus factores asociados, junto a la falta de evidencia en contextos nacionales y regionales, especialmente en poblaciones de internos de medicina a nivel Bolivia, La paz.

Desde esa perspectiva, el presente estudio aspira aportar información relevante que contribuirá a la generación de evidencia científica sobre el síndrome de Burnout y sus factores asociados. Los resultados de dichos cuestionarios podrán ser utilizados para analizar, comprender y posteriormente diseñar estrategias de intervención orientadas a la mejora del bienestar físico, mental y psicológico de los internos de medicina de los hospitales públicos de La paz, con el fin de optimizar las condiciones de formación y trabajo de los futuros profesionales de la salud.

6. MARCO REFERENCIAL

6.1. ANTECEDENTES

6.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En un estudio internacional realizado por Godia J, Pifarré M, Vilaplana J, Solsona F, Abella F y colaboradores en 2022 titulado “A Free App for Diagnosing Burnout (BurnOut App): Development Study”, se desarrolló una aplicación digital orientada a la detección y seguimiento del síndrome de Burnout en profesionales de salud. La investigación tuvo como objetivo diseñar una plataforma tecnológica accesible que permitiera aplicar cuestionarios validados relacionados con agotamiento emocional, despersonalización y realización personal mediante un sistema digital. La aplicación facilitó el almacenamiento y procesamiento de la información obtenida, permitiendo realizar un monitoreo continuo del estado psicológico de los trabajadores sanitarios. Los resultados del estudio evidenciaron que las herramientas digitales y plataformas web representan un método eficiente para la identificación temprana del síndrome de Burnout, además de mejorar la accesibilidad, confidencialidad y rapidez en la recolección de datos. Los autores concluyeron que la implementación de aplicaciones tecnológicas puede contribuir significativamente al seguimiento de la salud mental y al desarrollo de estrategias preventivas en el personal sanitario, constituyéndose en un antecedente importante para investigaciones que utilizan plataformas web en la evaluación del síndrome de Burnout (14).

Otro trabajo encontrado relacionado con el síndrome de burnout en médicos corresponde al estudio titulado “Prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en España: revisión sistemática y metaanálisis”, realizado por los doctores Antonio Pujol-de Castro, Grecia Valerio-Rao, Pablo Vaquero-Cepeda y Ferrán Catalá-López, y publicado en 2024 en la revista científica Revista Clínica Española. Este trabajo tuvo como objetivo estimar la prevalencia del síndrome de burnout entre los médicos en España, evaluando las tres dimensiones del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal (15).

El estudio fue de tipo cuantitativo, observacional y de corte transversal, y se desarrolló bajo un diseño de revisión sistemática con metaanálisis. Para su elaboración, los autores analizaron 67 estudios seleccionados de un total inicial de 1,616 artículos, los cuales incluían datos de 16,076 médicos españoles. Los criterios de inclusión consideraron estudios con herramientas de evaluación estandarizadas, principalmente el Maslach Burnout Inventory (MBI), que mide de manera específica las tres dimensiones del síndrome; los resultados principales, el metaanálisis reveló que la prevalencia global del burnout fue del 24% cuando se consideraba el síndrome completo, es decir, con afectación de las tres dimensiones. Sin embargo, al considerar la afectación de al menos una dimensión, la prevalencia se elevó considerablemente hasta un 51%, lo que indica una alta carga emocional y desgaste profesional en el colectivo médico (15).

El análisis por dimensiones específicas, el agotamiento emocional fue la dimensión más afectada, con una prevalencia de 40%, seguida de la despersonalización (30%) y de la baja realización personal (27%). El estudio también identificó factores riesgo asociados, entre ellos: largas jornadas laborales, falta de reconocimiento profesional, escasa conciliación entre la vida laboral y personal, y presión asistencial constante, especialmente en entornos hospitalarios (15).

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es la variabilidad en los resultados dependiendo de la especialidad médica, el entorno de trabajo (hospitalario o de atención primaria), y los criterios diagnósticos aplicados. Además, los autores señalaron que existe una falta de protocolos institucionales efectivos en muchos centros sanitarios para prevenir el síndrome de burnout, lo cual representa un problema de salud pública tanto para los profesionales como para la calidad de atención a los pacientes (15).

Este trabajo concluye que el síndrome de burnout está presente en una proporción significativa de médicos en España, y que su abordaje requiere estrategias integrales que incluyan la promoción de la salud mental, la intervención organizacional, y la formación en habilidades de afrontamiento emocional, tanto a nivel preventivo como terapéutico. Este antecedente aporta una base sólida al presente estudio, al ofrecer

un panorama nacional del problema, respaldado con una metodología rigurosa y evidencia cuantitativa reciente (15).

Un estudio relevante es el titulado “Estresores académicos como predictores da síndrome de Burnout em estudantes”, desarrollado por Sílvia G. Câmara, Francielle P. Nunes y colaboradores, y publicado en 2024 en la Revista Brasileira de Educação. Esta investigación tuvo como propósito examinar la influencia de los estresores académicos en el desarrollo del síndrome de burnout en estudiantes universitarios de distintas áreas del conocimiento en Brasil (16).

El trabajo se enmarca dentro de un diseño cuantitativo, transversal y correlacional, y contó con la participación de 1.169 estudiantes universitarios. Para la recolección de datos, se aplicaron cuestionarios validados que evaluaron tanto las dimensiones del burnout agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal como los principales estresores académicos, entre los que destacan la sobrecarga de tareas, las exigencias de evaluación y el tiempo de dedicación a los estudios(16).

Los resultados evidenciaron que los estresores académicos actúan como predictores significativos del síndrome de burnout, siendo el agotamiento emocional la dimensión más afectada. Los autores señalaron que los estudiantes con mayores niveles de presión académica presentaban una mayor tendencia a experimentar cansancio extremo, desinterés por las actividades académicas y sentimientos de ineficacia personal(16).

El estudio concluye que las condiciones del entorno académico desempeñan un papel determinante en el bienestar psicológico de los estudiantes, y recomienda la implementación de estrategias institucionales orientadas a la prevención y manejo del estrés académico, tales como programas de acompañamiento psicológico, promoción de hábitos saludables y desarrollo de habilidades de afrontamiento(16).

En el año 2020, en Nicosia, República de Chipre, Nteveros A, Kyprianou M, et al. realizaron un estudio, en el cual el objetivo principal fue estimar la prevalencia de Burnout en estudiantes de medicina de la Universidad de Chipre, siendo uno de sus objetivos secundarios determinar la relación de este con la calidad de sueño. La

calidad de sueño se evaluó con el cuestionario: Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg (PSQI) y el SBA con Maslach Burnout Inventory (MBI-SS)(17).

Los resultados obtenidos fueron que un 18.1% de los estudiantes padecen Burnout, y que de estos un 90.9% tenían más probabilidades de obtener una mala calidad de sueño (OR 4.33, $p = 0.023$) y peor salud mental(17).

Dentro del contexto latinoamericano y cerca al boliviano se realizó el estudio titulado “Factores asociados al síndrome de Burnout en estudiantes de la Universidad Ricardo Palma en el periodo 2017” fue realizado por los investigadores responsables Prof. Lucy E. Correa López, Prof. Dr. Jhony A. De La Cruz Vargas y Prof. Dr. Miguel Perez, et. al. de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú (18).

El estudio es cuantitativo, analítico, prospectivo y transversal, realizado mediante encuestas a una muestra de 337 estudiantes universitarios de diversas facultades: 223 de Medicina Humana, 56 de Ciencias Económicas y Empresariales, 5 de Ciencias Biológicas y 53 de Ingeniería. La prevalencia de Burnout encontrada fue del 31%, y entre las variables sociodemográficas analizadas, solo la edad mostró una asociación significativa (OR = 2,166; IC 95%: 1,345–3,488; $p = 0,001$), mientras que sexo, vivir con los padres, dependencia económica y tener hijos no mostraron asociación (18).

El estudio define el Burnout académico como una respuesta extrema al estrés crónico derivado del contexto educativo, incluyendo agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal según el Maslach Burnout Inventory. Los autores concluyen que la presencia de Burnout en un porcentaje considerable de estudiantes representa un problema relevante y que los factores asociados requieren un análisis más profundo, incluyendo variables psicológicas, contextuales y de estilo de vida, para comprender mejor la aparición del síndrome en esta población (18).

En un estudio realizado por Calderon Ramos LD, Villalba Arestigue TM, Soriano Moreno AN y Cabanillas León AR en 2025, titulado “Síndrome de burnout y calidad de sueño en estudiantes de Medicina en la etapa clínica de la Universidad Peruana

Unión (UpeU) durante 2022”, se investigó la asociación entre el síndrome de burnout y la calidad del sueño en estudiantes de medicina durante la etapa clínica. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, observacional y de corte transversal, incluyendo a 253 estudiantes de medicina. Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios validados como el Maslach Burnout Inventory (MBI - URPMS) y el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), permitiendo evaluar las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización, realización personal y calidad del sueño. Los resultados evidenciaron una asociación estadísticamente significativa entre el agotamiento emocional, la despersonalización y la mala calidad del sueño. Asimismo, se identificó una alta prevalencia de agotamiento emocional y alteración del sueño en los estudiantes evaluados. Los autores concluyeron que el síndrome de Burnout se relaciona significativamente con el deterioro de la calidad del sueño, resaltando la importancia de implementar estrategias preventivas y de apoyo psicológico en estudiantes y profesionales del área de salud, constituyéndose en un antecedente relevante para investigaciones relacionadas con Burnout y factores asociados al bienestar físico y mental (19).

Un estudio en Scielo Venezuela (afrontamiento y bienestar) demuestra que los estilos de afrontamiento incluyen significativamente en el burnout , mostrando que mejores estrategias de afrontamiento se asocian con menores niveles de este síndrome(20).

Asimismo, investigaciones recientes indican que la estrategia centradas en la emoción, como la evitación se asocia con mayor afectación psicológica, mientras que las estrategias activas ayudan a reducir el impacto del estrés

Otro estudio en Scielo Colombia relación afrontamiento y burnout , señala que existen una relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el síndrome de burnout, donde el uso de estrategias inadecuadas incrementan el riesgo de agotamiento emocional(21).

6.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES

En Bolivia, las investigaciones sobre el síndrome de Burnout en población universitaria aún son escasas; sin embargo, algunos estudios recientes permiten evidenciar la presencia y relevancia de este fenómeno en el contexto académico nacional.

Un estudio realizado por Salinas Nina (2023), titulado “Prevalencia y distribución del síndrome de Burnout Student en estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés”, identificó una prevalencia del 14,4 % del síndrome en esta población, siendo la dimensión de agotamiento emocional la más afectada, con un 54,4 % de los casos. Aunque el estudio no abordó directamente los trastornos del sueño, sus resultados reflejan el impacto del estrés académico y la carga emocional en los estudiantes de educación superior en Bolivia, evidenciando la necesidad de investigar los factores asociados al bienestar mental en este grupo(22).

En un estudio en la Universidad Adventista de Bolivia, los estudiantes del área de salud enfrentan una incidencia de estrés mayor que sus pares de otras áreas. El síndrome de Burnout (SB) es un estado emocional derivado de una sobrecarga de estrés que impacta la motivación, actitudes y conductas. Aunque muchos estudios se centran en profesionales de salud y educación, no se encontraban investigaciones previas para estudiantes de salud en Bolivia(22).

Con el objetivo de conocer las características del SB en estudiantes de salud de la Universidad Adventista de Bolivia (UAB), se seleccionó una muestra de 200 estudiantes inscritos en gestión 2015, aplicándose la escala Maslach Burnout Inventory (MBI). Los resultados mostraron que el SB se presentó en el 3 % de los casos, siendo mayor en mujeres. Por carrera, se encontraron 1 % en fisioterapia, 1 % en enfermería y 1 % en nutrición. La dimensión de agotamiento emocional se presentó en el 27 % de los estudiantes. Se observó que trabajar además de estudiar y ser de género femenino eran variables que aumentaban la tendencia a padecer SB, y que las tres dimensiones del síndrome mostraron una proporción de >15 % en este grupo de estudiantes(23).

En el contexto hospitalario se tienen antecedentes en médicos residentes, un estudio realizado por Huaricallo A, Angel M, Zalles G, Vanessa C, Ipavi Z, et al. en médicos residentes el hospital de clínicas de La Paz se logró identificar que los residentes que estaban realizando sus estudios en el área clínica tenían más probabilidades de desarrollar síndrome de Burnout en el futuro, sobretodo por la desrealización personal, y cansancio emocional más alto en comparación a las especialidades que son del área quirúrgica (24).

Asimismo un estudio realizado en el hospital Japonés en la ciudad de Santa Cruz titulado: “síndrome de burnout y factores asociados en el personal de salud del hospital japonés , bolivia” se identificó que el personal de salud con mayor probabilidad de desarrollar síndrome de Burnout tanto médico como enfermero eran los que tenían atenciones más de 4 pacientes diariamente, presentando una alta prevalencia con la despersonalización. También concluye en que era el personal médico quien tenía mayor prevalencia a desarrollar el síndrome de Burnout (25).

6.2. MARCO TEÓRICO

Desde una perspectiva actual, el Burnout se define como un síndrome multidimensional compuesto por tres dimensiones principales. El agotamiento emocional se refiere a la fatiga física y mental persistente con pérdidas de energía. La despersonalización implica actitudes frías, distantes o clínicas hacia los pacientes y el entorno laboral. La baja realización personal se caracteriza por una percepción de ineficacia, disminución del logro profesional y pérdida de satisfacción en el desempeño de actividades(15).

En el ámbito académico, especialmente en estudiantes de ciencias de la salud, el síndrome de Burnout se evalúa mediante el Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI - SS), instrumento que permite medir sus dimensiones adaptadas al contexto estudiantil: agotamiento emocional, cinismo (equivalente a la despersonalización) y eficacia académica (inversa a la realización personal). Este instrumento presenta adecuada validez y confiabilidad para la evaluación del Burnout en estudiantes universitarios, incluyendo internos de medicina(15).

Por otro lado, el nivel de estrés percibido, considerado un factor determinante en el desarrollo de Burnout, se evalúa mediante la Escala de Estrés Percibido (PSS - 10). Este cuestionario mide el grado en que las situaciones de la vida son valoradas como estresantes, permitiendo identificar la percepción subjetiva de estrés en el individuo durante el último mes. La PSS-10 es ampliamente utilizada por su simplicidad, validez y aplicabilidad en poblaciones académicas y clínicas(16).

En el contexto de los internos de medicina, el desarrollo del síndrome de Burnout se ve favorecido por factores como la sobrecarga académica, las jornadas prolongadas, la responsabilidad clínica temprana, la presión asistencial y la privación del sueño. Estas condiciones generan un estado de estrés sostenido que supera los mecanismos de afrontamiento del individuo, incrementando su vulnerabilidad(16).

Las consecuencias de Burnout son significativas tanto a nivel personal como profesional. Se asocia con trastornos emocionales como ansiedad y depresión, alteraciones de sueño y deterioro del estado general de salud. En el ámbito clínico, se relaciona con disminución del rendimiento, alteraciones en la toma de decisiones, incremento del riesgo de errores médicos y deterioro en la calidad de atención del paciente, constituyendo un problema relevante en los sistemas de salud (16).

6.2.1. FACTORES DE RIESGO

6.2.1.1. INVENTARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (COPE)

El síndrome de Burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se desarrolla como consecuencia de la exposición prolongada al estrés, especialmente en contextos de alta exigencia académica y laboral, esto ocurre en los internos de medicina y el personal de salud. Este síndrome se caracteriza principalmente por agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal, afectando negativamente el bienestar psicológico, el rendimiento académico y la calidad de atención hacia los pacientes.

En este contexto, las estrategias de afrontamiento del estrés cumplen un papel fundamental, ya que representan la manera en que una persona responde, maneja o

intenta adaptarse frente a situaciones difíciles, tensiones emocionales y demandas del entorno. Dependiendo del tipo de afrontamiento utilizado, estas estrategias pueden actuar como factores protectores o como factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de burnout(26).

El inventario de Afrontamiento al Estrés (COPE) es un instrumento psicológico diseñado para evaluar las diferentes estrategias que utilizan las personas para enfrentar el estrés. La versión completa del cuestionario está conformada por 42 ítems que permiten identificar conductas y respuestas emocionales frente a situaciones problemáticas o estresantes. Entre las dimensiones evaluadas se encuentran el afrontamiento activo, la planificación, la búsqueda de apoyo emocional, la reinterpretación positiva, la aceptación, la religión, la evitación, la desconexión conductual y el consumo de sustancias(26).

La relación entre el cuestionario COPE y el síndrome de burnout radica en que las estrategias de afrontamiento influyen directamente en la capacidad del individuo para manejar el estrés. Las personas que utilizan estrategias adaptativas, como la planificación, el afrontamiento activo o la búsqueda de apoyo emocional, suelen presentar una mejor capacidad de adaptación y menor probabilidad de desarrollar agotamiento emocional. Estas estrategias permiten enfrentar los problemas de manera más organizada y disminuir el impacto psicológico generado por las exigencias académicas y hospitalarias(26,27).

Por lo contrario, las estrategias de afrontamiento desadaptativas, como la negación del problema, la evitación, el aislamiento, la desconexión emocional o el consumo de alcohol y sustancias, se relacionan con mayores niveles de estrés crónico y desgaste emocional. Estas conductas dificultan el manejo adecuado de las situaciones estresantes y aumentan el riesgo de presentar síndrome de burnout(26,27).

En la presente investigación, el Inventario de Afrontamiento al Estrés (COPE) será utilizado para identificar las estrategias de afrontamiento empleadas por los internos de hospitales públicos de La Paz frente a las exigencias y presiones propias del internado rotatorio. La aplicación de este instrumento permitirá analizar si los

participantes utilizan mecanismos de afrontamiento adecuados o inadecuados y determinar su relación con la presencia y el nivel de síndrome de burnout(26,27).

De esta manera, el cuestionario COPE constituye una herramienta importante para comprender cómo las formas de afrontar el estrés pueden influir en el desarrollo del agotamiento físico y emocional en los internos de medicina, permitiendo identificar posibles factores de riesgo y contribuir al diseño de estrategias de prevención y apoyo psicológico dentro del ámbito hospitalario(26,27).

6.2.1.2. SATISFACCIÓN LABORAL

El síndrome de Burnout se manifiesta como un desgaste integral, físico, mental y emocional derivado de una exposición persistente a entornos de alta presión, una realidad común entre estudiantes de medicina y profesionales sanitarios. Este cuadro clínico se define por tres pilares críticos: el agotamiento emocional, la despersonalización y una percepción reducida de logro personal, factores que impactan severamente tanto la estabilidad psicológica como su capacidad académica y la excelencia del servicio brindado al paciente. Estos síntomas impactan negativamente el bienestar psicológico, la calidad del trabajo y las relaciones laborales, y pueden ser especialmente relevantes en áreas como el sector de la salud, la educación y otras profesiones de alta exigencia(28).

La satisfacción laboral juega un papel importante en la prevención del síndrome de Burnout, ya que refleja el grado en que los trabajadores se sienten felices y realizados en su entorno de trabajo, factores como el ambiente laboral, las relaciones interpersonales, las políticas organizacionales y la remuneración son componentes cruciales que influyen en la satisfacción del empleado. Un entorno de trabajo que promueve el bienestar y apoya la autorrealización del trabajador, tiene el potencial de disminuir la probabilidad de desarrollar Burnout. La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) es un instrumento diseñado para medir la satisfacción laboral en función de varios factores, como condiciones físicas y materiales del trabajo, beneficios laborales, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal y

desempeño de tareas. Cuenta con 36 ítems que evalúan dimensiones críticas que contribuyen al bienestar del trabajador y la prevención del síndrome de Burnout(28).

La relación entre la satisfacción laboral y el Síndrome de Burnout es compleja e importante, ya que los trabajadores que experimentan altos niveles de satisfacción laboral tienden a experimentar un menor grado de agotamiento emocional y despersonalización. Un entorno laboral que valora a sus empleados promueve el desarrollo profesional y ofrece condiciones laborales óptimas y, a su vez, contribuye a un mayor compromiso y bienestar. La insatisfacción laboral, derivada de factores como la falta de apoyo organizacional, un entorno tóxico o la sobrecarga laboral, se asocia con un mayor riesgo de padecer síndrome de Burnout. Los factores de la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) sirven en la prevención del síndrome de Burnout. Un ambiente de trabajo que favorece la comodidad puede reducir el estrés laboral y prevenir el agotamiento físico, los beneficios laborales y remuneración son otro factor clave(28).

La percepción de recibir una compensación adecuada, junto con beneficios adicionales, influye de manera crucial en la motivación y el bienestar general de los empleados. La equidad y la justicia en la aplicación de las políticas laborales son fundamentales para evitar la insatisfacción, la falta de normas claras y una administración percibida como injusta pueden aumentar el estrés, las relaciones sociales, la interacción positiva con compañeros y superiores, como la falta de apoyo social en el trabajo puede generar un sentimiento de aislamiento, lo que aumenta el riesgo de agotamiento emocional. El desarrollo, las oportunidades para el crecimiento profesional y la autorrealización están estrechamente relacionadas con el compromiso laboral ya que la falta de estas oportunidades puede fomentar el sentimiento de despersonalización, lo que es uno de los aspectos centrales del Burnout. El desempeño de tareas influye en la satisfacción laboral, cuando percibe que su trabajo es valorado y relevante, su nivel de satisfacción laboral tiende a ser mayor, reduciendo así el riesgo de desgaste emocional. El presente análisis establece que, a través de la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, se puede identificar la relación directa entre los factores de satisfacción y el nivel de Burnout en los trabajadores, en este caso personal de salud. La aplicación de este

instrumento es útil para diagnosticar áreas problemáticas en el entorno laboral y diseñar estrategias para prevenir el Síndrome de Burnout (28).

6.2.1.3. CALIDAD DE SUEÑO

La relación entre el síndrome de burnout y los trastornos del sueño en estudiantes de Medicina ha sido ampliamente investigada. Propusieron modelos que sugieren 2 posibles mecanismos responsables de estos trastornos: el agotamiento crónico de las reservas de energía y la activación del eje hipotalámico pituitario suprarrenal, que conlleva niveles elevados de estrés corporal. Los altos niveles de burnout se correlacionan con una peor calidad del sueño y una mayor prevalencia de insomnio en esta población. Se ha evidenciado que un sueño de calidad y duración adecuada facilita procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje, la concentración y la integración sensorial y motora. Por otro lado, la mala calidad del sueño está asociada con problemas de salud mental y un mayor riesgo de agotamiento emocional(19).

La calidad del sueño es un concepto bastante complejo, sin embargo, se considera un importante indicador de calidad de vida. En el ámbito de la salud, no solo hace referencia al hecho de dormir bien durante la noche, sino también al adecuado funcionamiento y desempeño de las actividades diarias.

La calidad del sueño comprende aspectos, entre ellos la duración adecuada del sueño, el tiempo necesario para conciliar, el periodo de vigilia, la mínima presencia de despertares nocturnos y la ausencia del consumo de medicamentos para dormir. Asimismo, se considera que un sueño es de buena calidad cuando logra completar todas sus fases sin interrupciones, permitiendo un descanso verdaderamente reparador.

De acuerdo con especialistas, para lograr una adecuada calidad de sueño es necesario completar los ciclos normales del sueño. En adultos jóvenes se recomienda dormir entre 7 y 9 horas por noche(19).

A. Dimensiones de calidad de sueño según Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh

El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (ICSP) es un cuestionario autoaplicable que permite evaluar de manera global la calidad del sueño mediante siete dimensiones o componentes. Fue elaborado por Buysse y colaboradores en la Universidad de Pittsburgh con el objetivo de analizar la calidad del sueño durante el último mes y posteriormente fue utilizado en diferentes investigaciones y ensayos clínicos(29).

B. Dimensión calidad subjetiva del sueño

Esta dimensión hace referencia a la percepción personal que tiene el individuo acerca de la calidad y cantidad de horas que duerme. Se considera subjetiva porque no requiere estudios especializados, sino que depende de la valoración y experiencia del propio sujeto(29).

C. Dimensión latencia de sueño

Comprende el tiempo que transcurre desde que la persona se acuesta hasta que logra quedarse dormir e iniciar la primera fase del sueño. Cuando el tiempo para conciliar el sueño supera aproximadamente los 20 a 30 minutos, puede considerarse una alteración de la calidad del sueño. Factores como el ambiente, la temperatura, la luz, el estrés, el dolor y el uso de medicamentos pueden influir en esta dimensión.

La latencia del sueño también se relaciona con la capacidad del individuo para quedarse dormido. La dificultad para conciliar el sueño suele presentarse con frecuencia en estudiantes y trabajadores del área de salud debido a los cambios constantes de horarios y la alteración de los ritmos biológicos, ocasionando consecuencias físicas y emocionales(29).

D. Dimensión duración del sueño

Se refiere a la cantidad de horas que duerme una persona, las cuales no deben ser insuficientes ni excesivas para lograr una adecuada recuperación física y mental. Durante el sueño se desarrollan ciclos conformados por fases No MOR y MOR, los cuales se repiten varias veces durante la noche y son fundamentales para el descanso del organismo.

La duración adecuada del sueño varía según la edad y diversos factores biológicos y ambientales. En adultos jóvenes se recomienda dormir entre 7 y 9 horas por noche para favorecer la restauración de energías y el adecuado funcionamiento físico y mental(29).

E. Dimensión eficiencia habitual del sueño

Esta dimensión evalúa el porcentaje de tiempo que realmente se duerme en relación con el tiempo total que la persona permanece en cama. Cuando el individuo pasa demasiado tiempo acostado sin poder dormir, se considera que el sueño tiene baja eficiencia.

En adultos jóvenes, la eficiencia normal del sueño oscila entre 90 % y 95 %. Una adecuada eficiencia del sueño favorece el rendimiento diario y el funcionamiento óptimo del organismo. Durante el sueño se producen importantes procesos fisiológicos relacionados con la regulación hormonal, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular(29).

F. Dimensión perturbaciones del sueño

Hace referencia a todas aquellas situaciones que interrumpen o dificultan el sueño durante la noche. Entre ellas se encuentran los despertares nocturnos, la necesidad de levantarse al baño, dificultad para respirar, tos, ronquidos, sensación de frío o calor, dolor, pesadillas y otros factores que alteran el descanso(29).

- **Despertares nocturnos**

Corresponden a las interrupciones del sueño después de haber conciliado el descanso. Estas alteraciones suelen relacionarse con el insomnio y pueden ocasionar somnolencia diurna, alteraciones del estado de ánimo y disminución del rendimiento diario.

- **Tener que levantarse para ir a los servicios higiénicos**

La necesidad de despertarse durante la noche para acudir al baño, también denominada nicturia, constituye una de las principales causas de interrupción del sueño y afecta negativamente la calidad de vida.

- **No poder respirar bien**

Se presenta cuando existe dificultad para mantener un adecuado flujo de aire durante el sueño debido a la relajación de estructuras de la vía aérea superior, ocasionando interrupciones del descanso.

- **Toser o roncar**

La obstrucción parcial de la vía aérea puede provocar ronquidos o tos durante la noche, generando despertares y alteraciones en la continuidad del sueño.

- **Pesadillas o malos sueños**

Las pesadillas son sueños desagradables asociados con ansiedad, preocupaciones o situaciones estresantes. Estas pueden provocar despertares nocturnos y afectar negativamente la calidad del sueño(29).

G. Dimensión uso de medicación para dormir

Esta dimensión evalúa la frecuencia con la que una persona utiliza medicamentos para conciliar o mantener el sueño. Los fármacos hipnóticos poseen efectos sedantes y relajantes, pero su uso inadecuado puede generar efectos adversos y alterar el patrón normal del sueño, por lo que deben utilizarse bajo indicación médica(29).

H. Dimensión disfunción diurna

Se refiere a la presencia de somnolencia, cansancio y necesidad de dormir durante el día. Esta alteración puede producir dificultades para realizar actividades diarias, disminución del rendimiento, cambios en el estado de ánimo, aumento del estrés y ansiedad.

La disfunción diurna suele provocarse por la privación del sueño nocturno, interrupciones del descanso o trastornos del sueño. El horario ideal para dormir se sitúa entre las 22:00 y 23:00 horas, ya que durante ese periodo de tiempo disminuyen la temperatura corporal y los niveles de cortisol, ayudando a la producción de melatonina y la conciliación del sueño(29).

6.2.1.4. HORAS DE SUEÑO

Las horas de sueño van a estar relacionados directamente con el metabolismo del cuerpo humano, este va a ser por diferentes factores y mecanismos.

A. Sueño y eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA)

El sueño y el estrés mantienen una relación bidireccional mediante varias vías neuroendocrinas que afectan el sistema nervioso central y el metabolismo la interacción de ambos podría dar el incremento de enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2.

El eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) constituye uno de los principales sistemas neuroendocrinos que están implicados, sigue un patrón llamado ritmo circadiano de 24 horas coordinado por el núcleo supraquiasmático (SCN), el cual actúa como marcapasos central. A través de proyecciones de vasopresina hacia el núcleo paraventricular (PVN), el SCN regula la liberación pulsátil de la hormona CRH. Este mecanismo biológico establece un ciclo donde los niveles de cortisol caen cerca de la medianoche, inician un ascenso progresivo pocas horas después de conciliar el sueño y logran su pico alrededor de las 9:00 a.m. Finalmente, la concentración de cortisol disminuye gradualmente durante el día(30).

B. Alteraciones del sueño y activación del eje HPA

Diversas situaciones estresantes, como la sobrecarga laboral y el bajo nivel socioeconómico, se asocian con reducción del tiempo de sueño y alteraciones neuroendocrinas.

La desalineación circadiana altera la arquitectura normal del sueño y modifica la secreción de cortisol, los cambios de fase en el horario de sueño producen

alteraciones importantes en la relación entre sueño de ondas lentas y sueño REM, estudios revisados muestran que los cambios en el ciclo sueño-vigilia generan modificaciones importantes en el sistema de estrés y podrían contribuir al desarrollo de alteraciones metabólicas(30).

C. Insomnio

Se define insomnio como un trastorno caracterizado por dificultad para iniciar, mantener el sueño, o tener un sueño no reparador asociado a un deterioro diurno.

Pacientes con insomnio presentan niveles elevados de cortisol, especialmente durante la noche y al inicio del sueño esto sugiere hiperactividad en el eje HPA además la fragmentación del sueño incrementa la liberación de cortisol, mientras que la hiperactivación del eje HPA favorece nuevas alteraciones del sueño, formando un círculo vicioso(30).

D. Privación del sueño

Además, de la restricción crónica del sueño, una condición frecuente en la sociedad moderna, se asocia con elevación del cortisol, especialmente durante la tarde y la noche, la privación del sueño altera la regulación normal del eje HPA y favorece una sobrecarga de glucocorticoides, generando efectos perjudiciales sobre el metabolismo. Asimismo, los estudios revisados muestran una asociación entre corta duración del sueño y aumento del riesgo de obesidad y diabetes mellitus tipo 2(30).

E. Estrés y metabolismo

El estrés mantiene una relación estrecha con el metabolismo a través de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA). Frente a situaciones estresantes se produce liberación de hormona liberadora de corticotropina (CRH), seguida de secreción de ACTH y posteriormente aumento de cortisol. El estrés crónico se asocia con obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y alteraciones en la composición corporal(30).

Los autores describen que el estrés influye en la conducta alimentaria la cual puede aumentar o disminuir la ingesta. Sin embargo, durante períodos de estrés psicológico existe tendencia al consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar(30).

Otro aspecto importante es el papel de la enzima 11 β -HSD1, encargada de transformar cortisol inactivo en cortisol activo dentro de los tejidos. Esta enzima se encuentra aumentada en el tejido adiposo de personas obesas y podría participar en el desarrollo del síndrome metabólico(30).

6.2.1.5. HORAS DE GUARDIA

Las horas de guardia corresponden a jornadas prolongadas de trabajo asistencial realizadas por el personal de salud fuera del horario laboral habitual, con el objetivo de garantizar la atención continua de los pacientes en los servicios hospitalarios. En internos y residentes de medicina, las guardias constituyen una parte fundamental de la formación clínica; sin embargo, la frecuencia y duración excesiva de estas jornadas puede generar disminución del tiempo de descanso y alteraciones en los patrones de sueño(31).

La privación del sueño asociada a las guardias hospitalarias prolongadas produce efectos negativos sobre el rendimiento físico, cognitivo y emocional. Entre las principales consecuencias se encuentran la fatiga, somnolencia diurna, disminución de la concentración, alteración de la memoria y reducción de la capacidad para la toma de decisiones clínicas. Asimismo, diversos estudios han relacionado las jornadas extensas de trabajo con mayor riesgo de estrés laboral, agotamiento emocional y síndrome de burnout en el personal médico en formación(31).

Un metaanálisis realizado por Itani O y colaboradores evidenció que dormir menos de 7 horas por noche se asocia con efectos adversos sobre la salud física y mental, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y deterioro del bienestar general. Además, el estudio identificó que la duración óptima

del sueño en adultos se encuentra entre 7 y 8 horas diarias, tiempo que frecuentemente no se cumple en internos de medicina debido a las largas horas de guardia hospitalaria. Por tanto, las jornadas prolongadas de trabajo representan un factor importante relacionado con el deterioro de la calidad de vida y del desempeño académico y asistencial del personal médico(31).

6.3. MARCO CONCEPTUAL

6.3.1. Síndrome de Burnout

Es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Aunque esta no es una enfermedad en sí misma, se reconoce como el detonante de otros problemas de salud física y mental más graves(1).

6.3.2. Estrés laboral

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés se define como el conjunto de reacciones fisiológicas que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Aunque los niveles moderados de estrés pueden ser útiles para el desempeño diario, cuando este se vuelve excesivo puede afectar negativamente la salud física, mental y emocional del individuo (32).

Según Gallup, Bolivia encabeza la lista de países con más estrés laboral en América Latina con un 55% de trabajadores con niveles elevados de estrés, se señala que factores como el entorno laboral, carga de trabajo, relaciones interpersonales sumado con la situación tanto económica, política y social que atraviesa el país constituyen de gran manera el aumento del estrés en la población (33).

En el ámbito del personal de salud, el estrés laboral en los profesionales de salud es causado por la interacción con su ámbito laboral, las exigencias del ambiente

exceden la capacidad de respuesta del trabajador causando en él una pérdida de control. En relación a los internos de medicina, el ingreso al internado médico representa una etapa de transición caracterizada por la incorporación del estudiante a la estructura jerárquica del sistema de salud donde asume nuevas responsabilidades y funciones.

Durante este período los internos enfrentan exigencias académicas y laborales simultáneamente lo que implica una doble condición como estudiantes en formación y personal que responde a las demandas hospitalarias. Estos se ven expuestos a situaciones clínicas complejas, toma de decisiones y una alta carga emocional, estos factores predisponen al desarrollo del estrés incorporando aún más probabilidades de desencadenar ansiedad y depresión. Estudiantes de medicina en Internado rotatorio. Los internos de los Hospitales públicos de la Paz (33).

6.3.3. Afrontamiento al estrés

El afrontamiento del estrés se refiere al conjunto de estrategias que utilizan las personas para enfrentar situaciones estresantes, incluyendo respuestas cognitivas y conductuales que pueden ser adaptativas (como la reestructuración cognitiva o la resolución de problemas) o desadaptativas (como la evitación o la negación)(34).

El síndrome de Burnout y el afrontamiento del estrés juega un papel fundamental en individuos que utilizan predominantemente estrategias de afrontamiento desadaptativas presentan mayor riesgo de desarrollar agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que son dimensiones centrales del Burnout. Por el contrario, el uso de estrategias adaptativas, como la reestructuración cognitiva y la resolución de problemas, actúa como un factor protector, reduciendo el impacto del estrés crónico laboral o académico(34).

Diversos estudios han demostrado que el afrontamiento del estrés tiene un papel fundamental en el desarrollo o prevención de burnout. En este sentido, las estrategias de afrontamiento pueden ser adaptativas o desadaptativas, influyendo directamente en el bienestar psicológico(21,27).

6.3.4. Satisfacción laboral

La satisfacción laboral se define como el grado de bienestar, agrado o conformidad que experimenta una persona respecto a su trabajo, en función de la valoración que realiza sobre sus condiciones laborales, relaciones interpersonales, remuneración y desarrollo profesional. Este constructo refleja la percepción subjetiva del trabajador sobre su entorno laboral y su experiencia en el mismo.(28)

La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional que incluye aspectos como el ambiente de trabajo, la carga laboral, el reconocimiento, la estabilidad laboral y las oportunidades de crecimiento. Cuando estos factores son percibidos de manera positiva, aumentan los niveles de satisfacción; en cambio, condiciones desfavorables generan insatisfacción y malestar.(28)

En el ámbito de la salud, especialmente en internos de medicina, la satisfacción laboral puede verse afectada por factores como largas jornadas, presión asistencial y exigencias académicas. Estos elementos influyen directamente en el bienestar emocional del individuo y en su desempeño profesional(28).

Es el grado de bienestar e inestabilidad observada entre la satisfacción laboral y el talento de la persona para ejecutarlas, originándose por la sucesión de manifestaciones presentes en el empleado y la intervención de factores que impactan al laburante. El trabajador no responde a la exigencia de su trabajo, mostrando un estrés agotador y desconfianza de sus facultades y evaluaciones personales, llevándolo al fracaso e indiferencia a su producción, impidiéndole desempeñarse y lograr satisfacción en el campo laboral(35)

Relación entre el síndrome de Burnout y satisfacción laboral: El síndrome de Burnout y la satisfacción laboral presentan una relación inversa, ya que altos niveles de agotamiento emocional y estrés laboral pueden disminuir la satisfacción laboral del trabajador(35).

La presencia del burnout puede afectar el desempeño laboral, las relaciones interpersonales y la calidad de atención brindada por el personal. En primer lugar,

disminuye el compromiso y la productividad, tienen más probabilidades de ausentarse con frecuencia o renunciar a sus puestos, lo que genera altos niveles de rotación de personal y costos(36).

La insatisfacción laboral produce un entorno de trabajo tóxico y poco saludable, sentimientos de desmotivación y negatividad entre colegas, dificulta el trabajo en equipo y la creatividad dentro de la organización, afectando la reputación y la imagen de la institución(36).

También se tiene repercusiones en la salud mental y física de los profesionales, afectando las relaciones interpersonales y el desempeño profesional. De igual manera influye la falta de apoyo, equidad, confianza y trato respetuoso entre el personal y la población. Lo más importante es encontrar un equilibrio entre el individuo y su entorno laboral(36).

Relación entre el síndrome de Burnout y satisfacción laboral: El síndrome de Burnout y la satisfacción laboral presentan una relación inversa, ya que altos niveles de agotamiento emocional y estrés laboral pueden disminuir la satisfacción laboral del trabajador(36).

La presencia del burnout puede afectar el desempeño laboral, las relaciones interpersonales y la calidad de atención brindada por el personal. En primer lugar, disminuye el compromiso y la productividad, tienen más probabilidades de ausentarse con frecuencia o renunciar a sus puestos, lo que genera altos niveles de rotación de personal y costos(35,36).

La insatisfacción laboral produce un entorno de trabajo tóxico y poco saludable, sentimientos de desmotivación y negatividad entre colegas, dificulta el trabajo en equipo y la creatividad dentro de la organización, afectando la reputación y la imagen de la institución(35,36).

También se tiene repercusiones en la salud mental y física de los profesionales, afectando las relaciones interpersonales y el desempeño profesional. De igual manera influye la falta de apoyo, equidad, confianza y trato respetuoso entre el

personal y la población. Lo más importante es encontrar un equilibrio entre el individuo y su entorno laboral(35,36).

6.3.5. Calidad de sueño

La calidad de sueño se define como la percepción que tiene una persona sobre su descanso y recuperación durante el sueño, considerando aspectos como la duración, latencia, continuidad y eficacia del sueño, así como las alteraciones que pueden presentarse durante las noches y su repercusión en las actividades diarias. Una adecuada calidad de sueño permite el correcto funcionamiento físico, mental y emocional, mientras que una mala calidad de sueño se asocia con fatiga, somnolencia diurna, disminución del rendimiento y alteraciones en la salud mental.

Buyse y Colaboradores desarrollaron el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), instrumento ampliamente utilizado para evaluar la calidad de sueño tanto en la práctica clínica como en investigaciones científicas(37).

Este cuestionario permite identificar alteraciones del sueño mediante la evaluación de diferentes componentes relacionados con el descanso y el funcionamiento diario del individuo(37).

6.3.6. Hora de sueño

Las horas de sueño se definen como el tiempo total que un individuo permanece dormido en un período de 24 horas, incluyendo el sueño nocturno y las siestas. Este componente constituye un elemento esencial para la recuperación fisiológica y mental, ya que permite la restauración de funciones cognitivas, emocionales y físicas(30).

Estudios muestran que hay un incremento de cortisol durante la privación total del sueño y durante la vigilia prolongada, este aumento probablemente refleja el estrés producido por el esfuerzo de permanecer despierto(31).

En el contexto del síndrome de Burnout, la disminución de las horas de sueño se asocia con un incremento de la fatiga, deterioro del rendimiento académico y laboral,

alteraciones en la concentración y mayor vulnerabilidad al estrés crónico. Por ello, su evaluación suele realizarse en términos de horas por día mediante autorreporte o instrumentos validados de calidad del sueño, considerándose generalmente insuficiente cuando es menor a seis horas diarias(30).

6.3.7. Horas de guardia

Las horas de guardia se refieren al tiempo continuo durante el cual el personal de salud permanece en funciones asistenciales o en disponibilidad laboral fuera del horario habitual, frecuentemente en turnos prolongados dentro de instituciones sanitarias. Estas jornadas extendidas representan una forma de carga laboral significativa, ya que implican demandas físicas y mentales sostenidas, muchas veces acompañadas de privación del sueño y alta responsabilidad clínica. En relación con el síndrome de Burnout, el aumento de las horas de guardia se vincula con mayor agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal. Su medición se realiza considerando la duración de cada guardia y la frecuencia semanal o mensual, siendo las guardias de 24 horas o más y su repetición frecuente factores que incrementan el riesgo de desgaste profesional(38).

7. HIPÓTESIS

1. Hipótesis de Investigación: Se puede determinar de manera positiva y significativa el nivel del síndrome de Burnout y los factores asociados en internos de los Hospitales públicos de La Paz mediante la implementación de una plataforma web, en el periodo de febrero-junio, 2026.
2. Hipótesis Nula: No se puede determinar de manera positiva y significativa el nivel del síndrome de Burnout y los factores asociados en internos de los Hospitales públicos de La Paz mediante la implementación de una plataforma web, periodo febrero-junio, 2026.
3. Hipótesis alternativa: Se puede determinar nuevos factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout en internos de hospitales públicos de La Paz mediante nuevas plataformas digitales y presenciales, en el periodo de febrero-junio, 2026.

7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

7.1.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ESTUDIO

CUADRO N° 1:CUADRO DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES QUE SE CONSIDERARÁN EN EL ESTUDIO

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR (valor de la variable)	TIPO DE VARIABLE
Agotamiento o emocional.	Dimensión del síndrome de Burnout caracterizada por la sensación de vacío y fatiga emocional extrema debido al trabajo.	Puntuación en la subescala de Agotamiento Emocional del Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS).	Suma de ítems (9 pregunta)	Cuantitativa discreta
Despersonalización	Dimensión del síndrome de Burnout que implica actitudes frías, clínicas e insensibles hacia los pacientes o el trabajo.	Puntuación en la subescala de despersonalización del MBI-HSS.	Suma de ítems (5 preguntas)	Cualitativa discreta
Realización personal	Dimensión del síndrome de Burnout que evalúa la sensación de competencia, logro y eficacia en el trabajo.	Puntuación en la subescala de realización personal del MBI-HSS.	Suma de ítems (8 preguntas)	Cualitativa discreta
Estrés laboral	Respuesta fisiológica y psicológica ante	Puntuación en la Escala de Estrés	Puntaje total	Cualitativa continua

	demandas laborales excesivas o mal gestionadas.	Laboral (OIT-OMS) o versión validada localmente.		
Horas de sueño	Número promedio de horas de sueño efectivo por noche.	Promedio de horas dormidos en los últimos 7 días (autorreporte).	Horas/noche	Cuantitativa continua
Horas de servicio	Tiempo semanal dedicado a actividades laborales-formativas en el hospital (incluye guardias y rotaciones).	Promedio de horas semanales reportadas durante el último mes.	Horas/semana	Cualitativa continua

FUENTE: Elaboración propia.

8. METODOLOGÍA

8.1.ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de investigación se refiere a la orientación que se adopta para abordar y resolver el problema de estudio, pudiendo clasificarse principalmente en: enfoque cuantitativo y cualitativo.

En la presente investigación se emplea el enfoque cuantitativo, el cual, según Hernández, se caracteriza por ser un proceso secuencial y probatorio, donde cada etapa sigue un orden lógico sin omitir pasos. A partir del planteamiento del problema se formulan preguntas de investigación, de las cuales se derivan hipótesis que posteriormente son sometidas a comprobación mediante la medición de variables en un contexto determinado (39).

Se opta por este enfoque debido a que se plantea un problema específico, se realiza la revisión de la literatura para la elaboración del marco teórico, se formulan hipótesis derivadas de la pregunta de investigación, se recolectan datos basados en la medición de variables y, finalmente, se analizan los resultados mediante métodos estadísticos específicos.

8.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la investigación se refiere al nivel de profundidad con el que se estudiará el fenómeno y a la estrategia que orienta el desarrollo del proyecto.

En la presente investigación se empleará un alcance correlacional, el cual, según Hernández, se define como un tipo de estudio que tiene como finalidad determinar la relación o grado de asociación existente entre dos o más variables dentro de una muestra o contexto específico. En este tipo de estudios se analiza cómo se comportan las variables en conjunto, sin establecer necesariamente una relación de causalidad (39).

Se opta por este alcance debido a que se pretende medir el grado de relación entre el síndrome de Burnout y los factores determinantes asociados, así como analizar el

comportamiento de dichas variables para obtener resultados concretos en la población de estudio.

8.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia estructurada que se adopta para responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos planteados.

En la presente investigación se empleó un diseño no experimental, de tipo transeccional (transversal) correlacional, el cual, según Hernandez, se caracteriza por la recolección de datos en un solo momento en el tiempo, permitiendo describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un contexto determinado, como una “ fotografía “ del fenómeno de estudio (39).

Se opta por este diseño debido a que se recolectan datos en un único momento, se analizará la relación entre las variables estudiadas y se interpretarán los resultados mediante análisis correlacionales, con el fin de obtener conclusiones fundamentadas sobre el comportamiento de dichas variables.

8.4. MÉTODO

El método de investigación se refiere a la forma sistemática mediante la cual se lleva a cabo el proceso investigativo, pudiendo clasificarse en métodos teóricos y empíricos.

En la presente investigación se emplea el método empírico de medición, el cual se define como un proceso basado en la recopilación de datos cuantitativos que permiten identificar regularidades y patrones en el fenómeno estudiado (39).

Se utiliza este método debido a que se recolectan datos cuantitativos precisos, los cuales serán analizados para establecer relaciones entre las variables y sintetizar los resultados en conclusiones que reflejen el comportamiento general de la población estudiada (39).

8.5. TÉCNICA

La técnica de investigación se refiere al procedimiento o manera de obtener datos de manera secuencial, se divide en 4,: análisis documental, análisis de contenido, observación, encuesta estructurada y entrevista.

En la presente investigación se utilizará la técnica de encuesta estructurada, esta se define, según Árias, como una técnica que pretende obtener información de un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación a un tema en particular (40).

Se utilizará esta técnica debido a que guardaremos los datos en un medio material, los datos podrán ser recuperados, y haremos uso de un instrumento propio de la encuesta, el cuestionario.

8.6. INSTRUMENTO

El instrumento de recolección de datos será por una encuesta digital estructurada, aplicada mediante una plataforma web especializada para detección temprana del síndrome de burnout y monitoreo psicoemocional en internos de medicina. Esta plataforma integra un “chat bot” conversacional y módulos automatizados de aplicación de escalas psicométricas validadas, permitiendo la captura, almacenamiento y procesamiento de información en tiempo real.

Según Hernández Sampieri, el instrumento se define como un cuestionario estructurado (instrumento compuesto por preguntas organizadas sistemáticamente para medir variables específicas), diseñado para evaluar factores asociados al síndrome de burnout(39).

La plataforma incorpora instrumentos psicométricos validados internacionalmente:

- Maslach Burnout Inventory (MBI): evalúa agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
- Perceived Stress Scale-14: cuantifica estrés percibido.

El sistema asimismo permitirá la recolección de variables sociodemográficas, académicas y clínicas, además de factores asociados como:

- horas de internado por semana
- calidad del sueño
- carga académica percibida

La aplicación del instrumento será periódica y automatizada, este se realizará desde dispositivos móviles, garantizando accesibilidad, anonimato y confidencialidad de la información recolectada. La plataforma cuenta con protocolos de seguridad, cifrado y acceso restringido para proteger datos sensibles de los participantes.

Los resultados obtenidos serán procesados automáticamente mediante algoritmos de clasificación de riesgo, generando reportes individuales y grupales que facilitarán el análisis de los factores asociados al síndrome de burnout y la identificación de estudiantes en riesgo para intervención temprana.

8.7. POBLACIÓN

Según Hernandez Sampieri la población se define como el conjunto de elementos o individuos que comparten características específicas y sobre las que se desea hacer una investigación. Por ende la población incluye a todos los internos que cumplen con los criterios de inclusión establecidos para el estudio(39).

La delimitación de la población se establece considerando criterios de contenido, lugar y tiempo. En cuanto al contenido, se incluyen únicamente internos de medicina que se encuentren en actividad clínica realizando su internado rotatorio, respecto al lugar, se dará en hospitales de la ciudad de La Paz, como el el Hospital Cotahuma, Hospital del Tórax, Hospital la Merced, Hospital La Paz, Hospital Los Pinos y Hospital Holandes, y en relación al tiempo, al período de estudio será de febrero a junio 2026.

Asimismo, se han establecido criterios de inclusión y exclusión con el fin de validación de resultados. Se considerarán como criterios de inclusión a los internos

de medicina que participen de manera voluntaria y que se encuentren realizando actividades clínicas durante el periodo de estudio. Por otro lado, se excluyen aquellos sujetos que no cumplan con estas características o que no completen adecuadamente los cuestionarios para la recolección de datos(39).

En el presente estudio se realizará en todos los internos, debido a la limitación de población de los participantes en los distintos hospitales públicos de La Paz.

8.7.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN

CUADRO N°2: CRITERIOS DE EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN QUE SE UTILIZARAN EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	ELIMINACIÓN
• Internos de medicina de pregrado que se encuentren realizando el internado rotatorio en los Hospitales de La Paz. • Internos de medicina con una permanencia mínima de 3 meses en el internado, con fin de garantizar la investigación. • Participantes que acepten voluntariamente formar parte del estudio mediante la firma del consentimiento informado.	• Internos que realicen su internado en instituciones privadas o fuera de la ciudad de La Paz . • Internos en periodo de licencia prolongada(académica, médica o personal) durante el periodo de recolección de datos.	• Que presenten cuestionarios incompletos con menos de un 90% de los ítems respondidos. • Proporcionen respuestas inconsistentes, incoherentes o con patrones repetitivos que sugieran falsa veracidad (sesgo de información). • Que retiren el consentimiento informado durante el desarrollo del estudio.

Fuente: Elaboración propia.

9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Para la recogida de datos se realiza, en internos de onceavo y doceavo de los hospitales La Paz. Se utilizó un cuestionario online, realizado en LAISO, durante el curso académico 2026. Para la aplicación de este cuestionario se acudió a cada uno de los internos en los que interesaba recoger datos. Se explicó al personal de salud la finalidad de la investigación, se informó sobre el anonimato de sus datos así como de la participación totalmente voluntaria en el estudio.

Para el procesamiento y análisis de los datos se empleó Microsoft Excel. Inicialmente, se evaluaron las propiedades psicométricas del instrumento (técnica de encuesta) utilizado para medir el síndrome de burnout y los factores asociados.

Posteriormente, se aplicaron análisis descriptivos, con el propósito de caracterizar a la población participante y describir las variables incluidas en el estudio.

Para examinar la relación entre el síndrome de burnout y los factores asociados seleccionados, se elaboraron tablas de contingencia. Estos análisis permitieron identificar posibles asociaciones entre las variables observadas.

10. PLAN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En la presente investigación se dará el resultado del planteamiento de problema y del objetivo general donde se darán los resultados de las encuestas aplicadas, las cuales se presentarán en tablas y gráficos estadísticos. El objetivo de dicha investigación es determinar la asociación entre el síndrome de Burnout y estrés en internos de los Hospital públicos de La Paz. Para explicar esta influencia se interpretarán los resultados de las encuestas realizadas en ilustraciones simples como gráficas de barras, ya que estas permiten una mejor visualización descriptiva del porcentaje de la población que puede presentar síndrome de Burnout y sus factores asociados, esto lograra que el lector o lectora entienda fácilmente la asociación negativa que existe entre el síndrome de burnout y sus factores asociados.

El informe estará respaldado por tablas y gráficos que visualizan los datos; también se adjuntan los ejemplares de la encuesta. Además, se realizará una exposición oral apoyada por diapositivas que incluyen esquemas visuales y gráficos, lo ayudará a la comprensión del tema, garantizando así una concientización sobre el tema expuesto.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUADRO N° 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

12. PRESUPUESTO

El presupuesto destinado para la investigación titulada “Síndrome de Burnout asociado al estrés laboral en internos de medicina de 25 a 45 años en hospitales públicos de La Paz” fue reducido, con un monto total de 100 bolivianos, debido a que la recolección de datos se realizó de manera virtual, lo que evitó gastos relacionados con impresión y material físico.

El principal gasto correspondió a la adquisición de bocaditos sencillos destinados a los participantes como incentivo, con un costo de 50 bolivianos. Asimismo, se asignaron 30 bolivianos para pasajes locales y 30 bolivianos para pequeños refrigerios dirigidos a los encuestadores, utilizados durante las actividades de coordinación y socialización del estudio.

En conjunto, el presupuesto se mantuvo dentro de un margen económico limitado, cubriendo los requerimientos básicos necesarios para favorecer la participación de los involucrados y garantizar la adecuada ejecución del trabajo de campo en modalidad virtual.

CUADRO N°4

RESUMEN DE INVERSIONES DE LOS GASTOS.

CANTIDAD	MATERIALES	COSTO bs.
100	Incentivo	100
9	Pasaje local	30
9	Pequeños aperitivos para los encuestadores	50
	TOTAL	180

Fuente: Elaboración propia

13. RESULTADOS

14. DISCUSIÓN

El síndrome de Burnout es un problema de la parte de la salud, especialmente en internos de medicina que se encuentran a bastante presión y expuestos a elevadas demandas académicas y asistenciales. En la presente investigación, se espera evidenciar una asociación significativa entre el estrés laboral y el desarrollo de Burnout, en el que identifican al estrés crónico como un factor determinante en su aparición.

Diversas investigaciones han reportado una alta prevalencia de Burnout en estudiantes y profesionales de la salud, donde la dimensión más afectada es el agotamiento emocional. Este componente se relaciona directamente con la sobrecarga laboral, las largas jornadas de guardia y la presión inherente al entorno clínico.

Asimismo, el estrés laboral constituye un factor clave del síndrome, ya que influye en los mecanismos de afrontamiento y en la estabilidad emocional de la persona. La exposición continua a situaciones demandantes puede favorecer la aparición de despersonalización y disminución de la realización personal, afectando tanto el bienestar del interno como su desempeño académico y clínico.

La calidad del sueño se perfila como una variable relevante en la relación con el Burnout. La evidencia señala que la privación del sueño y los trastornos del descanso se asocian con alteraciones cognitivas y emocionales, lo cual incrementa el riesgo de estar con estrés y agotamiento. En este contexto, se espera que los internos con peor calidad de sueño presenten mayores niveles del síndrome. En cuanto a las limitaciones, el diseño transversal del estudio nos permitirá establecer asociaciones, pero no relaciones causales. Asimismo, el uso de instrumento (cuestionario) introducirá sesgos de información; estos cuentan con adecuada validez y confiabilidad en la medición de las variables estudiadas.

Finalmente, los hallazgos esperados podrían contribuir al desarrollo de estrategias orientadas a la prevención del Burnout en internos de medicina, mediante intervenciones enfocadas en el manejo del estrés, la promoción del autocuidado y la mejora de las condiciones laborales, con el fin de optimizar tanto la salud mental del personal en formación como la calidad de atención brindada.

15. CONCLUSIONES

16. BIBLIOGRAFÍA

1. Merchán galvis am, albino matiz ay, bolaños lópez je, millán n, arias pinzón aa. síndrome de burnout y factores asociados en estudiantes de medicina. educ med super. 2020;32(3). disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v32n3/a14_1377.pdf
2. Espinosa pire I, hernández bandera n, tapia salinas ja, hernández coromoto y, rodríguez placencia a. prevalencia del síndrome de burnout en estudiantes de medicina. eev cubana reumatol. 2020;22(1).
3. Nagarajan R, Ramachandran P, Dilipkumar R, Kaur P. Estimación global del agotamiento profesional entre el personal de salud pública: una revisión sistemática y metaanálisis. Hum Resour Health [Internet]. 2024;22(1):30. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12960-024-00917-w>
4. Caldichoury-obando n, ripoll-córdoba d, breiner morales-asencio, ibañez-Reyes S, yuliana flórez, reyes-cervantes c, et al. burnout en profesionales sanitarios de américa latina durante la pandemia de covid-19. revista colombiana de psiquiatría. 2024 may 1;
5. Godoy Guzman FD, Illa Choquetarqui JA. Síndrome de Burnout en estudiantes de medicina: estudio longitudinal durante la pandemia Covid-19 y post pandemia. salud pública en acción [Internet]. 2024;e1–10. Disponible en: https://ojs.umsa.bo/index.php/med_spa/article/view/spa_vol5_n2_2024_spa3
6. (Salinas nina, w. a. 2023. prevalencia y distribución del síndrome de burnout student en estudiantes de medicina de la universidad mayor de san andrés. revista de la universidad san francisco xavier de chuquisaca. disponible en: <https://revistas.usfx.bo/index.php/bs/article/view/1422>)
7. McPeck-Hinz E, Boazak M, Sexton JB, et al. Clinician Burnout Associated With Sex, Clinician Type, Work Culture, and Use of Electronic Health Records. JAMA Netw Open. 2021;4(4):e215686. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.5686

8. Matteson, M. T., & Ivancevich, J. M. (1987). Controlling work stress: Effective human resource and management strategies. Jossey-Bass.
9. Vázquez-Ortiz J., Vázquez-Ramos M. J., Álvarez-Serrano M., Reyes-Alcaide M., Martínez-Domingo R., Nadal-Delgado M. y Cruzado J. A. (2012). Intervención psicoterapéutica grupal intensiva realizada en un entorno natural para el tratamiento del burnout en un equipo de enfermería oncológica. *Psicooncología*, 9(1), 161-182.
https://doi.org/10.5209/rev_PSIC.2012.v9.n1.39145
10. Parra Muñoz, J, Tigreros Urrego, J, Giraldo Buitrago, Y, Urruchurtu Aponza, K Prevalencia de síndrome de Burnout en personal que labora en puestos de liderazgo en una institución de salud de alta complejidad del Valle del Cauca, Colombia. [Internet]. Manizales: Universidad Católica de Manizales; 2025
11. Athié Gutiérrez C, Cardiel Marmolejo LE, Camacho Aguilera J, Mucientes Avellaneda VM, Terronez Girón AM, Cabrera Mora NA, et al. Burnout en médicos internos de pregrado del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. *Inv Ed Med*. 2016;5(18):102-107. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.020>
12. Cappelletti Santamaría A. Semiología Psiquiátrica y Psicopatología [Internet]. Lima: Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma; 2017. Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/a85fdd7a-0315-47a3-a352-aa962fb36b49/content>
13. Maslach C, Jackson SE. MBI: Inventario de Burnout de Maslach. Síndrome del quemado por estrés laboral. 4a ed. Madrid: TEA Ediciones; 1997. Disponible en: <https://psicogerontologiauneve.com/wp-content/uploads/2013/01/mbi-inventario-de-burnout-de-maslach.pdf>

14. Godia J, Pifarré M, Vilaplana J, Solsona F, Abella F, Calvo A, et al. Aplicación gratuita para el diagnóstico del síndrome de Burnout (BurnOut App): estudio de desarrollo. JMIR Medical Informatics. 2022;10(9):e30094. doi:10.2196/30094.
15. Pujol-de castro, a., valerio-rao, g., vaquero-cepeda, p., & catalá-lópez, f. (2024). prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en españa: revisión sistemática y metaanálisis. gaceta sanitaria, 38, 102384.
16. Camara SG, Carlotto MS. Estressores acadêmicos como preditores da síndrome de burnout em estudantes. Rev Bras Educ. 2024 ;29(e290020). Disponible en: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-24782024000100211&lng=es&nrm=iso
17. Ferreyra vera, d. y. (2023). trastorno del sueño relacionado al síndrome de burnout en estudiantes de enfermería de una universidad de ica 2021. Nteveros a, kyprianou m, artemiadis a, charalampous a, christoforaki k, cheilidis s, et al. burnout among medical students in cyprus: a cross-sectional study. plos one. 2020;15(11): e0241335.
18. Correa-lópez I, de la cruz-vargas ja, pérez m, loayza-castro ja, cabello-vela cs, huamán-garcía mo, vargas-vilca m, vilca-tapullima c. factores asociados al síndrome de burnout en estudiantes de la universidad ricardo palma en el periodo 2017. lima: universidad ricardo palma; 2017. disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/90d3682a-44f9-4fec-8d1b-109b39b4677f/conten>
19. Calderon ramos Id, villalba arestigue tm, soriano moreno an, cabanillas león ar. síndrome de burnout y calidad de sueño en estudiantes de medicina en la etapa clínica de la universidad peruana unión (upeu) durante 2022. educ médica. 2025;26(2):100990. disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1575181324001050>

20. Folkman, S. (2013). Stress: Appraisal and Coping. In: Gellman, M.D., Turner, J.R. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_215
21. Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology. 1989;56(2):267–83. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2926629/>
22. (Salinas nina, w. a. 2023. prevalencia y distribución del síndrome de burnout student en estudiantes de medicina de la universidad mayor de san andrés. revista de la universidad san francisco xavier de chuquisaca. disponible en: <https://revistas.usfx.bo/index.php/bs/article/view/1422>)
23. Morales EEP. Síndrome de burn-out en estudiantes de la facultad ciencias de la salud de la universidad adventista de Bolivia. CES. 2015 ;1(1):31–7. Disponible en: <https://www.uab.edu.bo/ojs/index.php/ces/article/view/111>
24. Huaricallo a, angel m, zalles g, vanessa c, irpavi z, av e, et al. burnout syndrome in resident doctors of the clinical hospital in la paz -bolivia articulos originales . rev med la paz. ;(1):31. available from: <http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v31n1/1726-8958-rmcmlp-31-01-13.pdf>
25. Cayoja n, libertad condori huanca g, milenca l, quispe h, ovando m, virginia m, et al.síndrome de burnout y factores asociados en el personal de salud del hospital japonés, bolivia burnout syndrome and associated factors in the care staff of the hospital japonés ,bolivia; available from: <https://rccsh.uagrm.edu.bo/wp-content/uploads/2024/12/Síndrome-de-Burnout-y-Factores-Asociados-en-el-Personal-de-Salud-del-Hospital-Japones-Bolivia.pdf>
26. Quiroz, N. R. López and Rosamaría Guadalupe. “Síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento en enfermeras del Hospital General de Chilpancingo Guerrero.” (2017).

27. Zakaria, NH, Zakaria, N. y Lee, KY. Relaciones entre el agotamiento y las estrategias de afrontamiento entre los auxiliares médicos en los centros de salud públicos de Malasia. *Sci Rep* 15 , 30058 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-14036-6>
28. Saire aragonez km, urure velazco in. síndrome de burnout y su relación con la satisfacción laboral del personal de enfermería en un hospital público del Perú. *rev enferm vanguard*. 2024;12(2):62-74. disponible en: <https://revistaenfermeriavanguardista.com/index.php/revista/article/view/129>
29. García CLC. Calidad de sueño y síndrome de Burnout en internos de enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, 2022. Universidad Nacional del Altiplano Repositorio Institucional - UNAP [Internet]. 2023;102. Disponible en: <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19994>
30. Hirotsu C, Tufik S, Andersen ML. Interactions between sleep, stress, and metabolism: From physiological to pathological conditions. *Sleep Sci*. 2015 Nov;8(3):143-52. doi: 10.1016/j.slsci.2015.09.002. Epub 2015 Sep 28. PMID: 26779321; PMCID: PMC4688585.
31. Itani O, Jike M, Watanabe N, Kaneita Y. Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Sleep Med*. 2017;32:246-56.
32. World Health Organization. Burn-out an “occupational phenomenon”: International classification of diseases. World Health Organization. World Health Organization; 2019. Available from: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>
33. Gallup I. State of the Global Workplace: Bolivia Country-Level Data . Gallup.com. Gallup; 2026 . Available from: <https://www.gallup.com/workplace/704642/state-global-workplace-bolivia-country-level-data.aspx>

34. Valdivieso-león I, ucas-mangas s, tous-pallarès j,sspinoza-diaaz I. estrategias de afrontamiento del estrés académico universitario. Educación XX1. 2020;23(2):165–186.
35. Martinez Jines SM, Chantong Cabrera KL, Naranjo Rios EL, Parra Martinez JC. Estudio del Burnout y la satisfacción laboral en profesionales de la salud en un hospital en Ecuador. Revista Vive. 2024 Sep 27;7(21):909–20.
36. Mamani A. Síndrome de Burnout y desempeño laboral en funcionarios de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés; 2021. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/33461/T-1586.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
37. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research 1989;28(2):193-213. doi:10.1016/0165-1781(89)90047-4
38. Hall SJ, Ferguson SA, Turner AI, Robertson SJ, Vincent GE, Aisbett B. The effect of working on-call on stress physiology and sleep: A systematic review. Sleep Medicine Reviews [Internet]. 2017 Jun 1;33:79–87. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1087079216300351>
39. Hernández-Sampieri R, Mendoza C. Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill Education; 2018.
40. Arias FG. El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta ed. Caracas: Episteme; 2012.

17. ANEXOS

ANEXO N°1

INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

SÍNDROME DE BURNOUT Y FACTORES ASOCIADOS

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar.

Su participación es completamente voluntaria, anónima y confidencial. El propósito de esta encuesta es identificar la posible asociación entre el síndrome de burnout y diversos factores sociodemográficos, académicos y psicosociales en estudiantes.

Primero, se le solicitará responder dos preguntas sobre su sexo y el nivel académico que cursa actualmente.

A continuación, encontrará un cuestionario compuesto por 22 preguntas relacionadas con el síndrome de burnout y 10 preguntas adicionales, en las cuales deberá marcar con una "X" la opción correspondiente (Sí o No).

Agradecemos sinceramente su tiempo y colaboración.

Señale su sexo con una "x" :

FEMENINO	
MASCULINO	

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados:

0= NUNCA.

1= POCAS VECES AL AÑO

2= UNA VEZ AL MES O MENOS

3= UNAS POCAS VECES AL MES

4= UNA VEZ A LA SEMANA

5= UNAS POCAS VECES A LA SEMANA

6= TODOS LOS DÍAS.

1	Me siento emocionalmente agotado/a por mis estudios.	
2	Me siento cansado al final de la jornada de estudio.	
3	Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de estudios me siento fatigado.	
4	Tengo facilidad para comprender cómo se sienten las personas	
5	Creo que estoy tratando a algunas personas como si fueran objetos impersonales.	
6	Estar todo el día con otras personas es un esfuerzo	
7	Creo que trato con mucha eficacia los problemas de las personas.	

8	Me siento desgastado por mi trabajo académico.	
9	Creo que estoy influyendo positivamente con mis estudios en la vida de los demás.	
10	Me he vuelto más insensible con la gente desde que estudio esta carrera.	
11	Me preocupa el hecho de que estudiar esta carrera me esté endureciendo emocionalmente.	
12	Me siento con mucha energía en mis estudios.	
13	Me siento frustrado/a en mis estudios.	
14	Creo que estoy estudiando demasiado.	
15	No me preocupa realmente lo que les ocurre a algunas personas con las que tengo que interactuar.	
16	Trabajar directamente con personas me produce estrés.	
17	Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las personas con las que estudio.	
18	Me siento motivado después de estudiar en contacto con personas.	
19	He conseguido muchas cosas útiles en mi carrera.	
20	Me siento acabado.	
21	En mis estudios trato los problemas con mucha calma	
22	Creo que las personas en mi entorno académico me culpan de algunos de sus problemas.	

ANEXO N°2

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL

SL-SPC

Autora: Sonia Palma

Lugar: Lima Perú

Año: 1999

colectiva

Forma de aplicación: Individual o

Edades de aplicación: Adultos de 18 a más

Número de ítems: 36

Tiempo de aplicación: 20 minutos

adultos.

Ámbito de aplicación: Sujetos

Normas de Corrección:

El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada ítem. Las puntuaciones utilizadas son: 5 Totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 indeciso, 2 en desacuerdo, Y total desacuerdo. Para los ítems negativos (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las puntuaciones de forma inversa, el puntaje que se puede alcanzar oscila entre 36 y 180. Los puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y los puntajes bajos insatisfacción frente al trabajo, existe además la posibilidad de obtener puntajes por áreas.

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE LA ESCALA DE "SATISFACCIÓN LABORAL" SEGÚN FACTORES SATISFACCIÓN LABORAL

SATISFACCIÓN LABORAL	FACTORES							P.T
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Alta satisfacción	23 - +	18-+	23-+	19-+	29-+	29-+	29-+	168-+
Parcial satisfacción	20 - 22	15- 17	20-22	17-18	26-28	26-28	25-28	49-167
Regular	15- 19	9-14	5 -19	12-16	19-25	20-25	19-24	12-148
Parcial insatisfacción	11 - 14	7-8	11-14	10-11	14-18	14-19	14-18	93-111

Alta insatisfacción	0- 10	0 - 6	0-10	0-9	0-13	0-13	0-13	0-92
---------------------	-------	-------	------	-----	------	------	------	------

Finalidad:

Medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los factores: Condiciones físicas y materiales, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas.

Componentes: La escala SL SPC consta de 36 proposiciones asociadas a 7 factores distribuidos de la siguiente manera:

Factor I Condiciones Físicas y/o Materiales (5 ítems). Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. Ítems son: 1, 13, 21, 28, 32

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 ítems). El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 2, 7, 14, 22

Factor III: Políticas Administrativas (5 ítems). El grado frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. Ítems son: 8, 15, 17, 23, 33

Factor IV: Relaciones Sociales (4 íte). Grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. Ítems son: 3, 9, 16, 24

Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems). Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. Los ítems correspondientes son: 4, 10, 18, 25, 29, 34

Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems). La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en la labora. Los ítems correspondientes son: 5. 11. 19. 26. 30,35

Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems). La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. Ítems son: 6, 12, 20, 27, 31, 36

Validez de la prueba: Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se obtuvo correlacionando el puntaje total de la Escala SL SPC con las del cuestionario de satisfacción laboral de Minnesota en una submuestra de 300 trabajadores. La validez es de 0.05.

Confiabilidad de la prueba: El coeficiente Alfa de Cronbach ítem puntaje total permitió estimar la confiabilidad, la confiabilidad obtenida es de 0.79.

ESCALA DE OPINIONES SL - SPC

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona.

Edad: Género: M() F()

Estado Civil: Soltero () Casado() Viudo () Divorciado () Conviviente ()

Tiempo de Servicio: Situación Laboral: Estable() Contratado ()

Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente laboral. A continuación te presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcando con un aspa a la alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde que la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que son solo opiniones.

Total Acuerdo: TA De Acuerdo: A Indeciso: I En Desacuerdo: D Total Desacuerdo: TD

	TA	A	I	D	TD
La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores					
2.Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizó					
3.El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones.					

4.Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.					
La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra					
6.Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(s)					
7. Me siento mal con lo que hago.					
8.Siento que recibo de parte de la empresa maltrato.					
9.Me agrada trabajar con mis compañeros					
10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.					
11. Me siento realmente útil con la labor que realizó.					
12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo					
13.El ambiente donde trabajo es confortable					
14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable					
15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando					
16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo					
17.Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo					
18. Me disgusta mi horario					
19. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo					
20. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia					
21. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia					
22. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable					
23. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.					

4. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo					
25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.					
26. Mi trabajo me aburre.					
27. La relación que tengo con mis superiores es cordial					
28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.					
29. Mi trabajo me hace sentir realizado.					
30. Me gusta el trabajo que realizo					
31. No me siento a gusto con mi(s)					
32. Existen comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.					
33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias					
34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a).					
35. Me siento complacido con la actividad que realizo.					
36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo					

ANEXO N°3

Estrategias de afrontamiento al estrés.

Marque con una X la opción que mejor represente el grado en que emplea una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican.

Escala: 0) Nunca 1) Pocas veces 2) A veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre.						
Búsqueda de apoyo social (BAS)		0	1	2	3	4
1	Trato de analizar las causas del problema para poder hacerle frente.					
2	Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrán mal.					
3	Intente concentrarme en los aspectos positivos del problema.					
4	Descargue mi mal humor con los demás.					
5	Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas					
6	Le conté a mis familiares o amigos como me sentía.					
7	Asistí a la iglesia					
8	Trate de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados.					
9	No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas					
10	Intente sacar algo positivo del problema.					
11	Insulte a ciertas personas.					
12	Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema.					
13	Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema.					
14	Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, pastor, etc.).					
15	Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo.					
16	Comprendí que yo fui la principal causante del problema.					

17	Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás.					
18	Me comporté de forma hostil con los demás					
19	Salí al cine, a cenar, a "dar la vuelta" para olvidarme del problema.					
20	Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema.					
21	Acudí a la iglesia para rogar que se solucione el problema.					
22	Hable con las personas implicadas para encontrar una solución al problema.					
23	Me sentí indefensa/o e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación					
24	Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes.					
25	Agredí a algunas personas.					
26	Procure no pensar en el problema					
27	Hable con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando estaba					
28	Tuve fe en que Dios remediara la situación.					
29	Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas.					
30	Me di cuenta que por mí misma/o no podía hacer nada para resolver el problema.					
31	Experimenté personalmente eso de que "no hay mal que por bien no venga".					
32	Me irrité con alguna gente.					
33	Practiqué algún deporte para olvidarme del problema.					
34	Practiqué algún deporte para olvidarme del problema.					
35	Recé.					
36	Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentar el problema.					
37	Me resigné a aceptar las cosas como eran.					

38	Comprobé que, después de todo, las cosas podrían haber ocurrido peor.					
39	Luché y me desahugué expresando mis sentimientos.					
40	Intenté olvidarme de todo.					
41	Procuré que algún familiar o amigo me escuchase para manifestar mis sentimientos.					
42	Acudí a la iglesia para poner velas o rezar.					